

- Evaluación cognitiva

Como se ha comentado anteriormente, la exploración de las capacidades cognitivas puede llevarse a cabo mediante la aplicación de una batería neuropsicológica más o menos extensa (exploración neuropsicológica sistematizada), o mediante el uso de pruebas para valorar de forma específica cada función cognitiva según el paciente (exploración neuropsicológica abierta). En ambos casos será necesario tener en cuenta, entre otros aspectos, tanto los objetivos de la evaluación como el grado de capacitación profesional que requieren los instrumentos a aplicar.

Mini Mental State Examination (MMSE), Folstein et al, 1975; Lobo y col., 2002.

Mini Examen Cognoscitivo (MEC), Lobo y col., 1979, 1995.

Memory Impairment Screen (MIS), Buschke y col., 1999.

Set-Test, Isaacs y Kennie, 1973; Pascual Millan y col., 1990.

Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ), Pfeiffer, 1975.

7-minute neurocognitive battery, Solomon y col., 1998.

Instrumentos cognitivos breves.

En la actualidad se dispone de un gran número de instrumentos psicométricos para la valoración de las capacidades cognitivas en las demencias, desde pruebas de **cribado** (tabla 4) hasta baterías extensas que requieren un tiempo considerable para su aplicación (tabla 5). Si bien en los últimos años se ha incrementado el número de estudios de adaptación y validación de estos instrumentos en población española, no es menos cierto que todavía es una práctica habitual utilizar pruebas traducidas directamente de su idioma original sin las garantías psicométricas adecuadas.

PRUEBAS COGNITIVAS INTERMEDIAS
✓ CAMCOG y CAMCOG-R (subescala cognitiva CAMDEX), Roth y col., 1986; Llinàs y col., 1991; Lozano y col., 2000. ✓ Test Barcelona abreviado (TB-A), Peña y col., 1997. ✓ Alzheimer's Disease Assessment Scale (ADAS), Rosen y col., 1984; Peña, 1997. ✓ Mattis Dementia Rating Scale, Mattis, 1976. ✓ Several Impairment Battery (SIB), Panisset y col., 1994; Llinàs y col., 1995.
BATERÍAS COGNITIVAS EXTENSAS
✓ Bateria Halstead-Reitan, Reitan y Davidson, 1974; Reitan y Wolfson, 1993. ✓ Bateria Luria-Nebraska, Golden, 1980; Boget, Hernández y Marcos, 1988. ✓ Bateria Luria-DNA, Manga y Ramos, 2000. ✓ Test Barcelona, Peña-Casanova, 1991.

Pruebas cognitivas intermedias.

- Evaluación de la gravedad global

Entre los objetivos de la exploración neuropsicológica de las demencias está el ofrecer una medida de la gravedad del deterioro en cada uno de los aspectos de las funciones cognitivas así como establecer la gravedad global del deterioro cognitivo (estadía de la demencia). Para ello, lo habitual es utilizar escalas diseñadas a tal efecto, que si bien no están exentas de críticas (especialmente porque la mayoría de ellas parten de la idea, no aceptada actualmente, de homogeneidad en el deterioro en la enfermedad de Alzheimer), son útiles para establecer una gradación del deterioro cognitivo que permita situar a cada paciente en cada fase de su enfermedad. Las más utilizadas a nivel internacional y en nuestro medio se resumen en la tabla 6.

✓ Global Deterioration Scale (GDS), Reisberg y col., 1982, 1988. ✓ Functional Assessment Staging (FAST), Reisberg, 1988. ✓ Clinical Dementia Rating (CDR), Hughes, Berg y Danzinger, 1988.
--

Pruebas cognitivas intermedias.

- Evaluación funcional

La evaluación multidimensional de las demencias debe incluir la evaluación del nivel funcional de los pacientes. Además de extraer datos de la entrevista, tanto con el paciente como con el informante,

pueden utilizarse escalas diseñadas para valorar las actividades de la vida diaria básicas, instrumentales y avanzadas (para una exhaustiva revisión Deví, Oliver y Cardona, 2004).

- **Evaluación de los síntomas psiquiátricos y conductuales**

Al igual que se comenta en el apartado anterior, para obtener una visión global del deterioro de un paciente con demencia, **es necesario valorar la presencia y alcance de las posibles alteraciones psiquiátricas y conductuales, que pueden incidir de forma más o menos directa en el rendimiento cognitivo y funcional del paciente** (para una exhaustiva revisión Deví, Magán y Ruiz, 2004).

- **Evaluación de la calidad de vida y sobrecarga del cuidador (impacto en el cuidador)**

En los últimos tiempos se han incorporado dos nuevas variables a tener en cuenta en el abordaje de las demencias en general: la calidad de vida del paciente y el impacto que la enfermedad tiene sobre el cuidador (sobrecarga). Si bien dentro del ámbito de la evaluación han aparecido multitud de entrevistas y escalas que miden ambas variables, actualmente disponemos de pocas que hayan sido validadas en España. Entre las más difundidas se encuentran la SmithKline Beecham Quality of Life Scale (SBQOL), de Dunbar y colaboradores (1992) que mide calidad de vida y la escala de sobrecarga del cuidador de Zarit y colaboradores (1980), validada en nuestro país por Martín y colaboradores en 1996.